PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN DE CASOS DE SUMISIÓN QUÍMICA

Redactado por:	**Aprobado por:**
Comisión Hospitalaria contra la Violencia FJD *Enero-2020*	*Comisión Hospitalaria contra la Violencia* *Comité de Dirección* *Enero-20*

CONTROL DE CAMBIOS RESPECTO A ULTIMA VERSIÓN		
Versión	**Fecha**	**Modificación**
0	Enero-20	Creación documento

PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN DE CASOS DE SUMISIÓN QUÍMICA

Código HUFJD 9.1/P22
Versión 0

INDICE

1. OBJETO Y ALCANCE....3
1. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA....3
1. DEFINICIONES....3
1. DESARROLLO....6
1.1.DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y VALORACIÓN INICIAL....6
1.1.1.ANAMNESIS DIRIGIDA....7
1.1.1.EXPLORACIÓN FÍSICA....8
1.1.1.REGISTRO EN HISTORIA CLÍNICA....9
1.1.1.ASPECTOS MÉDICO-LEGALES....9
1.1.1.1.MUESTRAS BIOLÓGICAS DE INTERÉS LEGAL....10
1.1.EXTRACCIÓN Y CUSTODIA DE MUESTRAS....11
1.1.2.PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE....11
1.1.3.RECOGIDA DE MUESTRAS DE ORINA....12
1.1.4.IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS....12
1.1.5.CUSTODIA DE LAS MUESTRAS....13
1. REGISTROS Y ANEXOS....14

1. OBJETO Y ALCANCE

La Sumisión Química (SQ) es un problema de Salud Pública que se asocia frecuentemente con agresiones sexuales o abuso de menores. La rápida intervención, el análisis toxicológico y toma de muestras biológicas permiten obtener la prueba científica de la SQ, el diagnóstico de certeza y el correcto tratamiento para la víctima.

El presente procedimiento se crea con la finalidad de aportar unas pautas de actuación normalizadas y homogéneas, profundizando en aquellos factores clave para el diagnóstico, así como en los procedimientos de actuación médico-legales y la coordinación entre los distintos niveles asistenciales.

Tiene como objetivos:

- Establecer un diagnóstico de sospecha de sumisión química, diferenciado de otros procesos como intoxicación por drogas o alcohol, posible psicopatología o trastornos neurológicos, para garantizar el correcto tratamiento y reinstaurar el nivel de salud de la víctima.
- Dar la respuesta medico-legal oportuna que garantice los derechos de la víctima, coordinando de forma adecuada con otras instituciones la toma de muestras biológicas para la identificación de agentes químicos de manera precoz.

Dirigido a los profesionales sanitarios del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, principalmente en el Servicio de Urgencias.

2. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

- Sistema de Gestión de la Calidad, ambiental y energética según las normas de referencia.
- Manual Corporativo del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, así como toda aquella documentación corporativa.
- Protocolo de Actuación ante Sospecha de Sumisión Química. Dirección General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria.
- Guía de Detección Clínica de la Sumisión Química. Hospital Universitario Clínico San Carlos.
- Recomendaciones del Ministerio de Justicia para la Preparación y Remisión de Muestras Objeto de Análisis por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

3. DEFINICIONES

Se define Sumisión Química (SQ) como “la utilización de agentes químicos para manipular la voluntad de las personas o modificar su comportamiento con fines delictivos, como agresión sexual, robo, extorsión y/o maltrato”. Las sustancias utilizadas principalmente son sustancias psicoactivas (Tabla 1), idealmente aquellas que presentan elevada actividad a dosis pequeñas, solubles en medio acuoso, sin apenas sabor ni olor, y de efectos rápidos. Los efectos buscados son: amnesia anterógrada, sedación, efectos alucinógenos y desinhibición.

Según como se produce la ingesta de la sustancia, podemos hablar de distintos tipos de sumisión química:

- SQ proactiva: intoxicación deliberada mediante la administración de una o varias sustancias y/o alcohol por parte del atacante y de manera encubierta a la víctima

- SQ oportunista: Ingesta voluntaria por parte de la víctima de una cantidad de sustancia/s y/o alcohol que provoquen un estado de intoxicación suficiente y que es aprovechado por el atacante
- SQ mixta: Confluye la ingesta voluntaria de sustancia/s y/o alcohol por la víctima con, además, administración encubierta por parte del atacante

TABLA 1. Principales Sustancias Empleadas en la Sumisión Química

FAMILIA	SUSTANCIA	FORMAS DE PRESENTACIÓN	VÍA DE ADM.	EFECTOS CLÍNICOS	DATOS RELEVANTES
Psico-estimulantes	Alcohol Etílico	Líqudo	Oral	Efecto depresor SNC, desinhibición, pérdida de capacidad de juicio. A dosis altas: pérdida de control corporal y de consciencia	Presente hasta en el 70% de los casos
	Cannabis	Hachís (resina) Marihuana (cogollos, flores)	Fumado (pipa, cigarrillo) Oral (alimentos)	Euforia, desinhibición, sedación, mareo, locuacidad, risa fácil, sensación de bienestar, inyección conjuntival, boca seca, taquicardia, mareos, ansiedad, cansancio, confusión. A dosis altas: angustia, pánico, ideas paranoides	Potencia efectos sedante y desinhibidor de otras sustancias
	Cocaína	Polvo de color blanco	Esnifada Fumada	Estimulación adrenérgica (taquicardia, HTA), euforia, incremento de energía, hiperalerta, aumento de autoestima. A dosis altas: ansiedad, palpitaciones, ideación paranoide	Uso como facilitador en delitos sexuales
	Anfetaminas	Polvo de color blanco, pastillas, cristales	Esnifado Fumado Inhalado Inyectado	Estimulación adrenérgica (taquicardia, HTA), euforia, incremento de energía, hiperalerta, aumento de autoestima. A dosis altas: ansiedad, palpitaciones, ideación paranoide. Efecto más prolongado que la cocaína.	Uso como facilitador en delitos sexuales
	MDMA (éxtasis)	Pastillas, cristales	Oral Esnifado	Estimulación, euforia, incremento de la empatía, ocasionalmente alucinaciones y delirios, ansiedad	Uso como facilitador en delitos sexuales

	Catinonas sintéticas (mefedrona)	Polvo	Oral Esnifado IV	Euforia, excitación, incremento de la empatía, ocasionalmente alucinaciones y delirios	No se detecta en orina de manera rutinaria

TABLA 1. Principales Sustancias Empleadas en la Sumisión Química

FAMILIA	SUSTANCIA	FORMAS DE PRESENTACIÓN	VÍA DE ADM.	EFECTOS CLÍNICOS	DATOS RELEVANTES
Anestésicos y disociativos	GHB (éxtasis líquido)	Líquido incoloro, inodoro, sabor ligeramente salado	Oral	Euforia, relajación, confusión, amnesia, incremento del deseo sexual, analgesia, relajación del músculo liso. A dosis altas: alucinaciones, convulsiones, coma, muerte	Uso como facilitador en delitos sexuales
	Ketamina (Special K)	Líquido, polvo	Oral Esnifado	Confusión, amnesia, sintomatología disociativo-alucinatoria (pérdida sensorial con analgesia y amnesia, sin pérdida de consciencia)	Uso como facilitador en delitos sexuales
Hipnóticos y sedantes	Benzodiazepinas	Pastillas, líquido, ampollas	Oral Disuelto en bebidas Inyectado	Triada: automatismo-desinhibición-amnesia anterógrada, sensación de borrachera, ataxia, mareo, disminución de nivel de conciencia	Las más utilizadas son las BZD de cinética, distribución y eliminación rápida
	Zolpidem Zoplicona	Pastillas, polvo	Oral Disuelto en bebidas	Amnesia, sedación, desinhibición, alucinaciones, comportamiento extraño	Vida media corta, fácil de administrar
	Barbitúricos	Pastillas, ampollas	Oral Disuelto en bebidas	Desinhibición, relajación, amnesia, somnolencia	Poco común Peligrosas a dosis altas
Opiáceos	Fentanilo Metadona	Pastillas, líquido	Oral Inhalado Fumado Inyectado	Placer, desinhibición, analgesia, sedación, depresión respiratoria	

Alcaloides tropanos	Escopolamina (Burundanga) Hiosciamida Atropina	Polvo: disuelto en bebida disuelto en crema	Oral: absorción rápida Tópico: absorción errática	Midriasis, sequedad de boca, taquicardia, visión borrosa, retención urinaria, desorientación, descoordinación de movimientos, amnesia anterógrada, síndrome anticolinérgico grave, puede llevar a coma y muerte	Intensa publicidad mediática, pero poco frecuente en la clínica. Difícil detección en sangre/orina
Otros	Inhibidores de la fosfodiesterasa (Viagra, Levitra, Cialis) Psicodélicos (LSD)				

4. DESARROLLO

4.1.DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y VALORACIÓN INICIAL

Es imprescindible un alto nivel de sospecha por parte de los profesionales sanitarios del Servicio de Urgencias (triaje) ya que los síntomas referidos por los pacientes suelen ser inespecíficos.

Podemos encontrar dos supuestos:

- Paciente con bajo nivel de conciencia, traído por algún acompañante, por SUMMA o por la policía.
- Paciente consciente, que acude solo o acompañado.

El comportamiento del paciente puede ser extraño, desorientado, confuso, angustiado, refiriendo malestar inespecífico. Puede que verbalice síntomas de mareo, visión borrosa, taquicardia, malestar. Asímismo puede referir síntomas o signos de agresión sexual o de haber sido inducido a facilitar dinero, joyas, propiedades, documentos, etc., de forma no libre, pero sin amenaza física o agresión.

La primera pregunta que realizaremos ante sospecha de SQ será "¿Puede ser que, de manera consciente o inconsciente, haya consumido una sustancia en las últimas horas?"

Se adjudicará en el **Formulario de Triaje de Casiopea** el motivo de consulta por el que acuda y, en función de la respuesta del paciente, quedará registrada en "Observaciones del motivo de consulta" la sospecha de SQ para las intervenciones médico-legales posteriores y su adecuada ubicación en el área asistencial correspondiente.

Se hablará con **Admisión de Urgencias** para la generación de Etiquetas Identificativas.

En **pacientes asintomáticos** en los que el tiempo transcurrido desde que supuestamente han sido víctimas de SQ hasta que son valorados por un médico sea **mayor de 72 horas**, no se considera necesaria la actuación urgente para la extracción de muestras, ya que la presencia en sangre de las posibles sustancias empleadas no supera dicho umbral. **La única muestra que debe ser recogida sería la muestra de orina**.

4.1.1.ANAMNESIS DIRIGIDA

Es fundamental conseguir un ambiente de entrevista clínica relajado, cómodo, tranquilizador, dejando tiempo suficiente al paciente para que se exprese libremente. Si lo desea el paciente, un familiar o acompañante puede acompañarle durante la entrevista clínica.

La anamnesis puede resultar complicada por la angustia del paciente; con frecuencia puede presentar amnesia total o parcial de los hechos, problemas del estado de alerta y del comportamiento, además de confusión y/o ansiedad.

Se recogerá el motivo de consulta, si cree haber sido víctima de algún delito y síntomas que presenta.

Es importante investigar el consumo voluntario de sustancias psicoactivas o tóxicas, con fines médicos o recreativos, que haya consumido tanto de forma aguda como crónica hasta el momento, por la posibilidad de que enmascaren o confundan los síntomas propios de la SQ. Es muy importante desculpabilizar y aclarar que no se juzga el consumo voluntario, sino que se intenta descubrir una posible intoxicación involuntaria con fines delictivos.

Se debe prestar especial atención a la presencia de determinados síntomas (TABLA 2). Se debe intentar describir la secuencia temporal de aparición de los síntomas, duración de los mismos, y si persisten o no en el momento de la entrevista.

TABLA 2. Síntomas de Sumisión Química

Ansiedad anterógrada	Incapacidad de memorizar hechos nuevos, y por tanto de aprender, pero no afecta a los hechos antiguos. En el caso de la SQ, se produce el síndrome amnesia-automatismo, con problemas de comportamiento, estado confusional, actitud de consentimiento y conducta automática, seguida de amnesia anterógrada total o parcial Se asocia a veces a confabulación. La amnesia es un efecto muy favorable para el agresor, ya que limita la información suministrada por la víctima (testimonio), al tiempo que retrasa (dificultando la toma precoz de muestras biológicas) o incluso, algunas veces, impide la denuncia del hecho delictivo (Sobre todo cuando la amnesia se asocia a un sentimiento de culpa)
Sedación	Disminución de la capacidad de vigilia, atención y de respuesta ante una agresión. El grado de sedación variará en función del delito cometido: ligera en casos de abusos sexuales o de la obtención de códigos bancarios, y mucho más profunda, próxima al sueño fisiológico, cuando se trata de robos. En ocasiones la víctima recupera la conciencia durante la agresión sexual, pero vuelve a desmayarse, incluso varias veces.
Efectos alucinógenos, con desorientación temporal y espacial	Con ello el agresor busca invalidar su testimonio. A veces se superponen a los recuerdos aislados que tiene la víctima, de modo que puede ser difícil de diferenciar ambos, lo cual dificulta todavía más la investigación
Desinhibición	Constituye una ventaja para el agresor en el curso de la agresión sexual, ya que la víctima puede aceptar situaciones que hubiera considerado intolerables en un estado de consciencia normal
Parálisis o paresias	Dificultad o alteraciones en la movilidad o sensibilidad de alguna parte del cuerpo, sin pérdida de consciencia
Disartria y alteraciones en el habla	
Alteraciones visuales	

Alteraciones de la motricidad o el equilibrio	
Resaca o síntomas extraños o inconsistentes con la cantidad de alcohol o drogas consumidos de forma consciente	

4.1.2.EXPLORACIÓN FÍSICA

Si se sospecha agresión sexual, la correspondiente exploración se realizará conforme al **Protocolo de Agresión Sexual**, por lo que no se realizará exploración genital de manera rutinaria y el resto de la exploración se regirá por las indicaciones del mismo (véase apartado "ante sospecha de violación" del HUFJD 29.4/P13 v0: Procedimiento de Intervención en caso de Violencia de Pareja hacia las Mujeres, ubicado dentro del Portal de Violencia y Maltrato de intranet FJD).
Es conveniente que se realice en presencia de testigos, al menos otro profesional sanitario, preferentemente del mismo sexo que la víctima, y si esta lo desea, también algún acompañante suyo.

Se debe extremar la precaución para no alterar la posible recogida de muestras posterior: utilizar guantes, no limpiar restos existentes sobre la piel, no retirar sustancias o materiales presentes...

Se realizará una exploración general por aparatos:

- Aspecto general: signos de violencia física (no suelen estar presentes, ya que la víctima no se resiste por el efecto del tóxico), TA, Tª, lesiones de piel y mucosas (hematomas, erosiones, restos del lugar en que haya estado adheridos a la piel...)
- Cabeza y cuello: especial atención a la boca, pelo...
- Tórax: AC y AP, posibles lesiones costales o musculares...
- Abdomen: dolor...
- Extremidades: dolor, contracturas, lesiones musculares...
- Neurológica: pupilas, motilidad, reflejos, fuerza y sensibilidad...
- Psicológica: amnesia, ansiedad, miedo...

Es aconsejable describir todas las lesiones encontradas e incluso acompañar la descripción minuciosa con un dibujo sobre una figura esquematizada del cuerpo humano, si fuera posible. Se debe prestar atención a la existencia de características diferenciadoras de los posibles tóxicos implicados, tal y como aparecen en la "TABLA 1. Principales sustancias empleadas para la sumisión química".

Si fuera preciso, por los síntomas referidos o por los hallazgos exploratorios, se realizarán las pruebas complementarias pertinentes, independientemente de las pruebas de carácter médico-legal que se realicen con posterioridad.

En cuanto a las pruebas complementarias, se seleccionará en Casiopea el **Perfil de Sumisión Química**, que incluirá la batería de pruebas pertinentes, así como los anexos de información y extracción de muestras con interés medico-legal.

La recogida de muestras siempre se realizará en medio hospitalario para garantizar la cadena de custodia en el manejo de las mismas, por lo que no se aceptarán muestras recogidas en otros elementos asistenciales, como Atención Primaria o SUMMA.

No se administrará medicación sedante hasta la recogida de muestras para el estudio por Toxicología, por la posible confusión diagnóstica o alteración de las muestras por fármacos administrados por los profesionales con fines terapéuticos. La sintomatología ansiosa de la víctima se tratará con técnicas de relajación y/o psicoterapia breve, sin administración de fármacos.

4.1.3.REGISTRO EN HISTORIA CLÍNICA

Al no existir un código específico, se registrará en la historia clínica informatizada con los siguientes códigos diagnósticos:

- CIE-9: 968.5 Intoxicación por estimulantes del SNC; 977.9 Intoxicación por fármacos (sin especificar), especificando la causa según el código E (E 962.9 Agresión por fármacos, sustancias sólidas, líquidas o gases)
- CIE-10: T50.903 A10000 Envenenamiento por fármacos, medicamentos y sustancias biológicas no especificadas, agresión, contacto inicial

4.1.4.ASPECTOS MÉDICO-LEGALES

Independientemente de que el/la paciente exprese su deseo de formular la correspondiente denuncia o no, y de la emisión del informe clínico asistencial, es obligatorio cumplimentar el documento “Parte de lesiones”, especificando claramente “Sospecha de Sumisión Química”

Asimismo, durante el ingreso en el Servicio de Urgencias, se cumplimentará por parte del facultativo responsable del caso la correspondiente **Notificación de Nuevo Caso**, dentro del Portal de Violencia y Maltrato de la intranet FJD, que se remitirá a la Comisión Hospitalaria contra la Violencia del HUFJD, que garantizará la informatización del registro y su accesibilidad para una posible revisión posterior con fines científicos, didácticos y/o de investigación.

El diagnóstico de SQ es complejo y está condicionado por numerosos factores como la demora en la solicitud de asistencia por parte de la víctima y la rápida desaparición en el organismo de algunos tóxicos, por cuanto es muy importante obtener precozmente las muestras biológicas y en las condiciones idóneas para su estudio.

Conviene tener presente que la persona reconocida puede percibir las preguntas acerca del consumo voluntario como un cuestionamiento de su credibilidad. Se debe explicar que los análisis de sangre y orina detectan alcohol, así como drogas o medicamentos, y que por este motivo es necesario precisar lo que ha tomado de manera voluntaria y en qué cantidad, para poderlo distinguir de lo que puede haber sido administrado sin su conocimiento.

Tras ello, **el médico responsable de la atención del paciente con sospecha de SQ, le facilitará la información para extracción y envío de muestras biológicas y solicitará por escrito la autorización para extracción de muestras biológicas de interés legal** (Anexos III y IV).

4.1.4.1.MUESTRAS BIOLÓGICAS DE INTERÉS LEGAL

Por muestras biológicas de interés legal, se entienden las muestras biológicas que nos permitan identificar los tóxicos empleados. Se deben tener en cuenta las Normas recogidas en la Orden JUS/1291/2010, de 13 de mayo, por la que se aprueban las normas para la preparación y remisión de muestras objeto de análisis por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) (Tabla 3).

TABLA 3. Recomendaciones del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

Recomendaciones del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses	
Muestras de elección	**Sangre venosa periférica**: informa del consumo reciente de una sustancia y permite correlacionar la concentración de la misma y el efecto clínico. Precisa recogida temprana porque los niveles de sustancia descienden con mayor rapidez en las muestras de sangre. **Orina**: permite un intervalo de tiempo de detección mayor para algunas sustancias
Muestras de empleo ocasional	No biológicas, relacionadas con el sujeto: fármacos encontrados en el lugar de los hechos, recipientes o utensilios empleados, jeringuillas, papelinas, elementos sospechosos. Cabello: sirve para distinguir la exposición única de la crónica y pone en evidencia un tóxico que habría desaparecido ya de sangre y orina
Otras	Parches de sudor: recomendado por la Asociación Norteamericana de Toxicología

En el Servicio de Urgencias se debe siempre tomar muestras de sangre y orina, ya que generalmente se desconoce la sustancia o sustancias que han sido empleadas, y disponer de ambas muestras para analizar permite un estudio mucho más completo, teniendo siempre en cuenta que los tiempos de detección en sangre y orina depende de la vida media del tóxico, de la dosis administrada y de la sensibilidad del método analítico (Tabla 4)

TABLA 4: Tiempo de detección de tóxicos en sangre y orina.

Sustancia	**V.M. Plasmática**	**Tiempo Ventana en Orina**
Alprazolam	6-27 horas	3 semanas
Cocaína	45-90 minutos	2-4 días
GHB	20 minutos-6 horas	8-12 horas
Etanol	2-14 horas	7-12 horas
Escopolamina	2-6 horas	12 horas
Lorazepam	9-16 horas	3 días
THC	20-36 horas	3-30 días

4.2. EXTRACCIÓN Y CUSTODIA DE MUESTRAS

La posterior utilización de las muestras en un posible proceso judicial requiere de unas garantías probables durante el proceso de extracción, traslado y análisis de las mismas. Por ello, **la recogida de muestras se realizará en las condiciones establecidas en el Documento de Cadena de Custodia para la preparación y remisión de muestras objeto de análisis por el INTCF**, en el que deben figurar los datos aportados en el **Anexo V**, lo cual asegura la garantía del proceso.

Además, para asegurar la validez del documento, se requiere la solicitud de la petición de análisis de la muestra a través de Casiopea por el médico responsable de la atención al paciente, la extracción de la muestra

supervisada por el médico a cargo del paciente, la confirmación inequívoca de la identidad del paciente en la hoja de extracción de laboratorio y etiquetas, y la identificación correcta del **Documento de Cadena de Custodia Interno (Anexo VI),** del que se imprimirán dos copias, una que acompañará la muestra y otra que se dejará una vez cumplimentada en el Servicio de Urgencias.

Antes de cualquier intervención, se informará a la víctima de nuestra actuación y su finalidad, obteniendo su consentimiento a través de la **Hoja de Información** (Anexo III) y la firma del **Consentimiento Informado** (Anexo IV), que quedará **firmado en la Historia Clínica** y de las cuales, **una copia se entregará al paciente, otra se adjuntará a las muestras**. Una vez firmado en Consentimiento, **se avisará a la Supervisora de Enfermería de Urgencia o de Guardia** de la existencia de un caso de SQ en el Servicio de Urgencias.

El profesional de enfermería realizará la extracción de las muestras en las condiciones que se definen a continuación, y **en presencia de dos testigos como mínimo**, uno de ellos será el **médico Adjunto que atienda al paciente y el otro la Supervisora de Enfermería del Servicio de Urgencias o de Guardia**, quien estará presente desde el momento de la extracción de la muestra hasta el almacenamiento de las mismas, para garantizar el mantenimiento de la cadena de custodia.

4.2.1.PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE

Se recomienda la extracción de sangre venosa periférica en **dos tubos de 5 ml**, **uno de ellos anticoagulado con EDTA y el otro con fluoruro sódico como conservante y oxalato potásico como anticoagulante (Kit de Muestra para Forense,** ubicado dentro del armario situado en la Farmacia General de Urgencias), procurando llenar los tubos al máximo, para evitar cámara de aire. Homogeneizar los tubos. **Mantener en frío desde ese momento (vaso con hielo)**. Para la **desinfección de la piel se utilizará agua y jabón o agua destilada**. Nunca emplear alcohol, tintura de yodo u otros disolventes con fracciones volátiles.

Kit de Muestra para Forense

De forma paralela a criterio del facultativo pueden extraerse muestras **(Perfil de Psiquiatría: analítica de sangre tóxicos en orina**) para analizar en nuestro Laboratorio de Urgencias con el procedimiento habitual.

4.2.2.RECOGIDA DE MUESTRAS DE ORINA

Para la recogida de orina se utilizará un **envase de cultivo de orina de 50 ml**. La recogida de la muestra deberá realizarse en el momento, en presencia de un profesional sanitario (enfermera/auxiliar de enfermería del circuito de urgencias correspondiente), no siendo aceptadas muestras aportadas por el paciente o acompañantes con anterioridad.

4.2.3.IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS

Una vez realizada la extracción, **se etiquetará con las propias etiquetas del paciente generadas por Admisión, tapando parcialmente los tubos de sangre, a modo de precinto. De igual forma se identificará el envase de recogida de orina.**

Los tubos de las muestras deberán permanecer a la vista del paciente mientras se etiquetan o, en su caso, tutor, acompañante o autoridad. Asimismo, debe haber dos testigos presentes en la identificación: el médico/a Adjunto responsable del caso y la Supervisora de Enfermería.

En la Historia Clínica, el facultativo que atiende al paciente reflejará que: *"en (fecha y hora) se realiza la extracción de (nº tubos) con (tipo de anticoagulante), para su entrega a la Policía o remisión al Instituto Nacional de Toxicología. Limpieza de la zona de extracción con (desinfectante utilizado). Supervisa y custodia la muestra (Dr/Dra Nombre y Nº Colegiado) y (Supervisor/a Nombre y Nº de Colegiado)".*

Se adjuntará a las muestras la solicitud del Documento de Remisión de muestras al INTCF (Anexo V), **el Documento de Cadena de Custodia Interno** (Anexo VI) **junto con la Hoja de Consentimiento Informado del paciente** (Anexo IV).

Las muestras se mantendrán, una vez extraídas, dentro de la bolsa del "Kit de Muestras para el Forense", que se precintará con una etiqueta del paciente, junto con las hojas correspondientes al Anexo IV, Anexo V y Anexo VI, que irán grapadas a dicha bolsa, por fuera.

4.2.4.CUSTODIA DE LAS MUESTRAS

Una vez extraídas las muestras, deberán ser almacenadas en el **Laboratorio de Urgencias**, en una nevera con cerradura, hasta su remisión y requerimiento de la autoridad competente.

Para mantener la cadena de custodia, en el traslado de las muestras al Laboratorio de Urgencias y su almacenaje, estará presente la Supervisora de Enfermería de Urgencias o de Guardia, acompañada por Personal de Seguridad del Hospital y/o Agente de las Fuerzas de Seguridad.

Todas las personas implicadas en la cadena de custodia firmarán el correspondiente "Documento de Cadena de Custodia" (Anexo VI), que se guardará junto al resto de documentos en el correspondiente Archivo Centralizado del Hospital. Una copia queda en el Servicio de Urgencias, otra se le dará a la persona a quién se entreguen las muestras, tras cumplimentar el apartado de "Recibí" con su identificación correspondiente. La entrega se realizará en el Laboratorio de Urgencias a petición de la Policía para ser analizado en su Laboratorio o será remitida al INTCF a petición del Juzgado.

Las muestras para custodia se almacenarán en una **nevera con candado específica del Laboratorio de Urgencias**. Estas muestras mantendrán en cadena de custodia a disposición de las Autoridades durante 90 días, transcurridos los cuales finaliza la cadena de custodia y las muestras serán destruidas o podrán emplearse

con fines científicos, si el paciente autorizó en el documento de consentimiento informado dicho uso. La Supervisora de Enfermería quedará encargada de la destrucción de las muestras a los 90 días si no han sido requeridas por Orden Judicial. La llave de la nevera estará bajo custodia de la Supervisora de Enfermería.

A continuación, se remitirá al paciente a la Comisaría o Juzgado para interponer la correspondiente denuncia (si esto no se hubiese realizado con anterioridad a solicitar atención médica), explicándole la necesidad de esta para continuar el proceso legal y poderse iniciar las acciones judiciales correspondientes.

Hay que tener en cuenta que:

- Si el paciente no es capaz de acudir a Comisaría para formular la denuncia, el profesional sanitario que le atiende puede valorar la conveniencia de llamar a la Policía (091)
- Si existe sospecha de delitos contra la libertad sexual, se actuará conforme al protocolo específico de agresión sexual vigente, comunicándolo al Jugado, y se recurrirá a la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía, quienes se personarán en el Centro Hospitalario si fuera necesario, o remitir a la paciente al CIMASCAM.
- Si exiten malos tratos a menores, tanto psicológicos como físicos, incluido el abuso sexual, se notificará al Grupo de Menores (GRUME) de la Policía, quienes se personarán en el Centro Hospitalario si fuera preciso.

5. REGISTROS Y ANEXOS

- ANEXO I. Algoritmo de Actuación ante Sospecha de Sumisión Química
- ANEXO II. Parte de Lesiones
- ANEXO III. Registro de Casos Específico
- ANEXO IV. Autorización para Extracción de Muestras Biológicas
- ANEXO V. Documento de Cadena de Custodia y de Remisión de Muestras al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
- ANEXO VI. Documento de Cadena de Custodia Interno